

La rate et le système porte

I – introduction

La rate est un organe lymphoïde en étroite connexion avec la veine porte. Sa situation dans la cavité péritonéale ne fait pas d'elle un organe de l'appareil digestif, si ce n'est que ses étroites rapports avec l'estomac, le pancréas, le côlon et les vaisseaux de ces organes. Elle joue un rôle dans l'immunité (maturation des lymphocytes), et dans l'épuration du sang en détruisant les hématies et les plaquettes vieilles.

II- Anatomie descriptive

1-Situation

Elle est située dans la loge sous phrénique gauche, à l'étage sus-mésocolique. À gauche et en arrière de l'estomac, au-dessus de l'angle colique gauche et du ligament phrénico-colique gauche. En avant du rein gauche. Au-dessous et en dedans de la coupole diaphragmatique gauche.

La rate est un organe thoraco-abdominal se projetant sur le grill costal gauche (de la 9^{ème} à la 11^{ème} côte). A l'état normal, la rate n'est pas palpable complètement caché par les côtes, sauf en cas d'augmentation de son volume on parle de splénomégalie.

2- Forme et dimensions

Elle a la forme d'un grain de café, sa couleur est rouge foncé, c'est un organe mou et friable. Poids : 150 à 200 grammes, longueur : 12 cm, largeur : 8 cm, épaisseur : 4 cm.

3- Moyens de fixité

La rate est complètement entourée de péritoine viscéral

- les organes de voisinage (rein en arrière, diaphragme latéralement, l'estomac en avant et médialement, l'angle colique gauche en bas)
- le ligament phrénico-colique gauche
- l'omentum gastro-splénique, et l'omentum pancréatico-splénique (la reliant à la queue du pancréas).
- les vaisseaux spléniques.

4- Configuration extérieure et rapports

Elle présente à décrire : deux faces

- Latérale ou diaphragmatique : convexe, elle répond au diaphragme et à la paroi thoracique.
- Médiale divisée en deux segments par le hile splénique (éléments du hile ; artère et veine spléniques, nerfs et lymphatiques) ;
 - Segment Antéro-médial ou gastrique : en rapport avec l'estomac.
 - Segment Inféro-médial ou rénal : concave, en rapport avec le rein gauche et la surrénale gauche.
 - Le hile splénique répond à la queue du pancréas

Deux extrémités :

- Crâniale ou sommet : de situation postéro-médiale, arrondie, regarde en arrière et en dedans.
- Caudale ou base : de situation antérolatérale, elle est large et concave, elle repose sur l'angle colique gauche.

Deux bords :

➤ Antérieur : crênelé et convexe, sépare la face diaphragmatique de la face gastrique. Il répond au rebord costal.

➤ Postérieur : mousse et épais, il sépare la face diaphragmatique de la face rénale. Il répond au rein gauche.

III- Vascularisation et innervation

1- Artérielle ; La vascularisation de la rate est assurée par l'artère splénique qui naît du tronc cœliaque, elle est sinueuse, elle a un trajet d'abord sus pancréatique longeant le bord supérieur du pancréas, puis devient rétro pancréatique, en arrière du pancréas, puis en avant de la queue pancréatique se plaçant dans l'omentum pancréatico-splénique pour se terminer en deux branches dans le hile de la rate.

Elle donne des branches collatérales :

- des rameaux ganglionnaires
- l'artère pancréatique dorsale.
- l'artère gastro-omentale gauche.
- l'artère œso-cardio-tubérositaire postérieure.
- les artères spléniques courtes.

2- veineuse : la veine splénique

Elle draine le sang veineux splénique, gastrique et pancréatique.

Elle naît au niveau du hile de la rate et chemine derrière le pancréas, reçoit la veine mésentérique inférieure et forme avec elle le tronc spléno-mésaraïque qui s'unit à son tour avec la veine mésentérique supérieure pour former la veine porte.

3- lymphatiques ; Représentés par les lymphonœuds du hile splénique.

4- les nerfs : viennent du plexus cœliaque (plexus solaire), ils suivent les vaisseaux spléniques formant à leur tour un plexus splénique.

IV – Le système porte

Un système porte est un système circulatoire qui relie deux réseaux capillaires de même type (veineux-veineux).

La veine porte ramène le sang veineux des organes du tube digestif, de la rate et du pancréas.

Elle débute par un réseau capillaire veineux au niveau des organes qu'elle draine et se termine dans le foie par un réseau capillaire veineux, il s'agit des capillaires sinusoides hépatiques (qui forment ensuite les trois veines hépatiques vers la veine cave inférieure).

C'est une volumineuse veine de 8 à 10 cm de long et d'un diamètre de 15 à 20mm.

a- origine

La veine porte est formée par la réunion derrière l'isthme du pancréas, de la veine mésentérique supérieure et le tronc spléno-mésaraïque. Ce dernier est formé par la réunion de la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. Le confluent portal est situé à hauteur de la deuxième vertèbre lombaire un peu à droite de la ligne médiane.

b- trajet

Elle monte obliquement en haut et à droite, d'abord rétro-duodéno-pancréatique, puis dans le pédicule hépatique (segment pédiculaire) dont elle constitue l'élément le plus postérieur, avec l'artère hépatique propre en avant et à gauche et les voies biliaires en avant et à droite. Le segment pédiculaire chemine dans le bord droit du petit omentum.

c- terminaison

Dans le hile hépatique en se divisant en deux branches droite et gauche. La branche droite continue la direction de la veine porte. La branche gauche s'écarte presque à angle droit de la veine porte.

d- branches affluentes

- la veine gastrique gauche drainant la petite courbure de l'estomac, elle se jette dans le flanc gauche du tronc de la veine porte à sa partie inférieure.
- la veine gastrique droite et la veine cystique se terminent à la partie moyenne du flanc gauche de la veine porte.
- la veine pancréatico-duodénale supérieure droite se jette dans le bord droit de la veine porte.
- la veine cystique se jette dans la branche droite de la veine porte.

e- territoire de drainage des branches d'origine de la veine porte

- L'artère mésentérique supérieure draine le sang veineux de de l'ensemble de l'intestin grêle, du côlon droit, du tiers droit du côlon transverse.
- L'artère mésentérique inférieure draine le sang veineux du haut rectum, le côlon gauche et deux tiers gauche du côlon transverse.
- L'artère splénique draine le sang veineux de la rate, la queue et le corps du pancréas, elle reçoit la veine gastro-épiploïque gauche qui draine la grande courbure gastrique et les veines gastriques courtes qui drainent le fundus.

Ainsi le système porte véhicule vers le foie la totalité du sang veineux du tube digestif et des glandes annexes.

f- Les anastomoses porto-caves

Le flux sanguin digestif rejoint la veine porte pour gagner le foie, dans le foie il passe par l'hépatocyte pour rejoindre la veine cave inférieure. Il existe des endroits qui sont drainés à la fois par des veines du système porte et des veines du système cave. Ces endroits sont le siège d'anastomoses porto-caves. Il existe dans le corps quatre endroits d'anastomoses porto-caves naturelles : le cardia, l'ombilic, le rectum et le péritoine.

Dans ces endroits le flux sanguin est normalement faible, ces veines peuvent se dilater quand le système porte ne permet pas au sang d'arriver au foie (obstruction portale), elles le dérivent vers le système cave.

- le cardia : la paroi de l'œsophage abdominal et le cardia est drainée à la fois par une veine du système porte (gastrique gauche) et par une veine du système cave (phrénique inférieure).

Dans ce territoire se développent des varices cardio-œsophagiennes en cas d'hypertension portale (HTP).

- Anastomoses veineuses ombilicales : se forment autour de l'ombilic soit entre les rameaux de la veine para-ombilicale (vestige de la veine ombilicale du ligament rond) et les veines sous cutanées abdominales tributaires de la veine cave inférieure, soit de la veine para-ombilicale et des veines pariétales se jetant vers le haut par les veines thoraciques internes (système cave supérieur). La veine ombilicale normalement obstruée en cas HTP elle redevient perméable avec dilatation des réseaux sous-cutanés (la circulation collatérale).

- le rectum : sa paroi est drainée à sa partie supérieure par les veines rectales supérieures (affluents de la veine mésentérique inférieure : système porte), dans sa partie basse par les veines rectales moyennes et inférieures (affluents de la veine iliaque interne ; système cave).

- le péritoine : le péritoine viscéral tapissant les viscères est drainé par le système porte, par contre le péritoine pariétal est drainé par le système cave, il peut se développer dans les accollements entre les deux péritoines des anastomoses porto-caves.

Références

H Rouviere Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle tome II tronc édi Masson 1986

P Kamina Abdomen appareil digestif et rein tome 2. Edi Maloine 2002



